CUESTIONARIO RESPIRATORIO 1	2024
1. Un paciente de 14 años consulta por disnea y malestar general, asociado a tos frecuente. Refiere que hace 15 días inició un cuadro catarral, con rinorrea y tos y que esta última fue aumentando, agregándose disnea de esfuerzo en el último tiempo. Al examen físico se auscultan algunas sibilancias y crepitaciones difusas. La radiografía de tórax muestra engrosamientos peribronquiales y un patrón alveolointersticial. El tratamiento más adecuado es:	a.Amoxicilina b.Ceftriaxona c.Levofloxacino d.Broncodilatadores + corticoides e.Amoxicilina + ácido clavulánico
2. Un paciente de 60 años, fumador, consulta por disnea que aparece al caminar una cuadra. Al examen físico presenta espiración prolongada y aumento del diámetro torácico. Se solicita una radiografía de tórax que muestra aplanamiento del diafragma, gases arteriales que son normales y una espirometría que muestra VEF1: 75% del teórico, CVF: 105% del teórico, VEF1/CVF: 60%. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar corticoides orales y suspender el cigarrillo b.Iniciar oxígeno domiciliario y suspender el cigarrillo c.Iniciar corticoides inhalados y suspender el cigarrillo d.Iniciar broncodilatadores inhalados y suspender el cigarrillo e.Iniciar antibióticos orales y suspender el cigarrillo
3. Un recién nacido postérmino, presenta un cuadro de dificultad respiratoria grave, con saturación arterial de 85% a FiO2 ambiental y aleteo nasal. Al examen físico se auscultan sibilancias bilaterales y se aprecia signos de hiperinsuflación pulmonar. El diagnóstico más probable es:	a.Enfermedad de membrana hialina b.Hernia diafragmática congénita c.Taquipnea transitoria d.Síndrome de aspiración meconial e.Cardiopatía congénita
4. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS compatible con una fibrosis pulmonar?	a.Hipocratismo digital b.Desaturación arterial con el ejercicio c.Crepitaciones pulmonares intensas d.Aumento de la capacidad vital forzada e.Radiografía con patrón intersticial en panal de abeja
5. Un paciente de 68 años, fumador de 30 paquetes-año consulta por malestar general y tos con expectoración, la que suele ser hemoptoica. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un nódulo pulmonar de 4,5 cm de diámetro, el que se confirma con el TAC, ubicado en el lóbulo superior izquierdo, sin adenopatías asociadas. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar broncoscopía b.Solicitar RMN de tórax c.Solicitar angioTAC de tórax d.Iniciar clindamicina endovenosa e.Realizar lobectomía pulmonar superior izquierda
6. Un paciente de 45 años es diagnosticado de TBC pulmonar bacilífera. Recibe 1 mes de tratamiento con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Se controla con una baciloscopía, la que resulta positiva. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar PPD y radiografía de tórax b.Solicitar PPD c.Mantener el tratamiento con los 4 fármacos y controlar en un mes con nueva baciloscopía d.Derivar para inicio de tratamiento en esquema secundario e.Solicitar TAC de tórax, de cortes finos
7. Un paciente presenta un cuadro de tos con expectoración y dolor tipo puntada de costado. Se solicita una radiografía que muestra una zona de relleno alveolar, asociada a un derrame pleural moderado. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido pleural turbio, con 2.000 células por mm3, 96% polimorfonucleares, con pH: 7,0, lactato: 12 mmol/L, LDH: 230 UI/L, proteínas: 7 g/dl y ADA: 100 UI/L. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar tratamiento antituberculoso b.Solicitar biopsias pleurales c.Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso e instalar un tubo pleural con trampa de agua d.Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso y drenar el drenaje mediante la toracocentesis e.Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso, biasociado, con cobertura para anaerobios
8. Un paciente asmático consulta por disnea de reposo, que no ha cedido a pesar del uso frecuente de salbutamol. Al examen físico está taquipneico a 28 rpm, con aumento del diámetro anteroposterior. Presenta sibilancias espiratorias intensas, bilaterales y uso de musculatura accesoria. Su saturación arterial es de 88% a FiO2 ambiental. La conducta más adecuada es:	a.Administrar oxígeno al 24%, nebulizar con salbutamol y administrar corticoides y antibióticos por vía endovenosa b.Administrar oxígeno hasta normalizar la saturación arterial, nebulizar con salbutamol y administrar corticoides por vía endovenosa c.Administrar oxígeno al 100% y conectar a ventilación mecánica no invasiva d.Administar oxígeno a 2 L/min, administrar adrenalina racémica y corticoides en nebulización e.Administrar oxígeno hasta normalizar la saturación arterial, nebulizar con salbutamol, administrar corticoides orales e iniciar ceftriaxona endovenosa
9. Un paciente sufre un traumatismo de tórax, con fracturas costales segmentarias que dejan una parte del tórax que se mueve de	a.Realizar resolución quirúrgica de inmediato y brindar soporte respiratorio

Lia...

manera independiente al resto de la pared torácica. Además evoluciona con dificultad respiratoria y desaturación arterial de 80%, a pesar de administrar oxígeno. La radiografía de tórax es compatible con una contusión pulmonar izquierda, sin neumotórax ni derrame pleural. La conducta más adecuada es:	b.Conectar al ventilador mecánico, con presión de ventilación positiva e iniciar analgésicos endovenosos c.Iniciar oxígeno al 100% y realizar nebulizaciones con salbutamol d.Conectar a BiPAP e instalar tubo pleural con trampa de agua e.Solicitar videotoracoscopía de urgencia e iniciar analgésicos y soporte respiratorio
10. Un niño de 8 años consulta por fiebre y odinofagia intensa que inició hace 24 horas y que le impide tragar. No ha presentado otros síntomas y al examen físico se aprecia febril hasta 40°C, con gran eritema faríngeo, con algunas petequias y exudado grisáceo en ambas amígdalas. Además se palpan varias adenopatías cervicales anteriores, dolorosas a la palpación. El agente etiológico más probable es:	a.Neumococo b.Rinovirus c.Virus influenza d.Streptococcus pyogenes e.Virus de Ebstein Baar
11. ¿Cuál de las siguientes conductas es MENOS indicada en un paciente EPOC cursando una neumonía y que satura 80% a FiO2 ambiental?	a.Iniciar oxígeno al 50% b.Administrar corticoides sistémicos c.Realizar nebulización con broncodilatadores de corta acción por vía inhalatoria d.Solicitar gases de sangre arterial e.Administrar antibióticos endovenosos
12. Un paciente de 20 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de 3 días de evolución de malestar general, asociado a fiebre, tos y expectoración mucopurulenta, al que luego se agregó disnea de pequeños esfuerzos. Al examen está vigil, con FC: 102 x', PA: 110/75 mmHg, FR: 33 rpm y saturación arterial 90% a FiO2 ambiental. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra signos de condensación en los lóbulos medio e inferior derechos. Su hemograma muestra leucocitosis de 19.000 por mm3. ¿Qué antibiótico es más adecuado?	a.Amoxicilina b.Claritromicina c.Ceftriaxona d.Amoxicilina + ácido clavulánico e.Clindamicina
13. Un paciente de 20 años presenta dolor torácico tipo puntada de costado, que inició hace 2 horas, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y saturación arterial de 98%. Se solicita radiografía de tórax, que muestra un neumotórax pequeño, que solo se ve en el ápice izquierdo, de 1 cm de ancho. La conducta más adecuada es:	a.Administrar analgésicos y observar por 4-6 horas, controlando con nueva radiografía de tórax b.Puncionar el segundo espacio intercostal de manera urgente c.Instalar tubo pleural de inmediato d.Solicitar un TAC de tórax e.Resolver quirúrgicamente de inmediato
14. Un paciente de 45 años sufre un accidente de tránsito con golpe en el tórax. Evoluciona con dificultad respiratoria y al examen físico se constata abolición del murmullo pulmonar izquierdo, con matidez a la percusión de dicho campo pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?	a.Contusión pulmonar b.Neumotórax c.Distrés respiratorio d.Hemotórax e.Lesión traqueobronquial
15. Un paciente de 60 años, diagnosticado de derrame pleural, se realiza toracocentesis diagnóstica, obteniéndose un líquido amarillo, transparente, con proteínas de 2,1 g/dl, LDH: 90 UI/l, células: 60 x mm3, con 80% mononucleares, pH: 7,4 y lactato: 3 mmol/l. Las proteínas plasmáticas son 6,4 g/dl y la LDH plasmática es 190 UI/l. El diagnóstico más probable es	a.Tuberculosis b.Cáncer c.Empiema d.Derrame paraneumónico simple e.Insuficiencia cardíaca
16. Un paciente presenta los siguientes gases arteriales: PaO2: 50 mmHg, PaCO2: 60 mmHg, pH: 7,24, HCO3: 25. ¿Cuál es el diagnóstico?	a.Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica b.insuficiencia respiratoria parcial con acidosis metabólica c.Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria d.Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis respiratoria e.Error en la toma de muestra, con gases venosos en lugar de arteriales
17. ¿Cuál de los siguientes es la mejor opción para un paciente alérgico a la penicilina, con una NAC de manejo ambulatorio?	a.Amoxicilina + ácido clavulánico b.Azitromicina c.Ceftriaxona d.Clindamicina e.Ampicilina + clorfenamina
18. El derrame pleural canceroso se caracteriza por ser:	a.Un trasudado pleural mononuclear b.Un trasudado pleural polimorfonuclear con pH normal

Lia...

	c.Un exudado pleural mononuclear d.Un exudado pleural polimorfonuclear con pH normal e.Un exudado pleural con ADA mayor a 50 UI/L
19. Un paciente de 68 años, presenta un cuadro de baja de peso y constipación de 2 meses de evolución, el que ha tratado con aumento de fibra en la dieta, sin lograr mejoría. Acude al servicio de urgencia por un cuadro de inicio súbito de disnea y dolor torácico de tipo puntada en el lado derecho. Al examen físico está sudoroso, taquipneico y taquicárdico, sin otras alteraciones. Satura 89% a FiO2 ambiental y la radiografía de tórax solo muestra un derrame pleural pequeño en el ángulo costofrénico derecho. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar antibióticos endovenosos y oxígeno b.Solicitar dímero D e iniciar oxígeno c.Solicitar angioTAC de tórax e iniciar oxígeno d.Instalar un tubo pleural y brindar soporte ventilatorio con BiPAP e.Conectar a ventilación mecánica
20. Un paciente asmático está en tratamiento con fluticasona inhalada, dos veces al día, la que usa con una aerocámara. Además usa salbutamol cuando está con síntomas. Presenta síntomas nocturnos cerca de 2 veces a la semana y tose con frecuencia, en especial después de realizar esfuerzos. La conducta más adecuada es:	a.Reemplazar la fluticasona por mometasona inhalada b.Reemplazar la fluticasona por prednisona oral c.Reemplazar el salbutamol por ipatropio d.Reemplazar el salbutamol por formoterol SOS e.Agregar salmeterol inhalado cada 12 horas al tratamiento

Lia...

CUESTIONARIO RESPIRATORIO 2	
1. Un paciente de 65 años, fumador de una cajetilla al día, consulta por disnea de esfuerzos de un mes de evolución. Al examen físico se constata aumento del diámetro anteroposterior del tórax, asociado a espiración prolongada y algunas sibilancias espiratorias. El diagnóstico más probable es:	a.Bronquiectasias b.Cáncer bronquial c.Bronquitis crónica d.Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e.Fibrosis pulmonar
2. Un paciente de 60 años, sintomático, se realiza una radiografía de tórax, como parte de un chequeo médico, que detecta un nódulo pulmonar solitario de 3 cm de diámetro en el lóbulo superior derecho. No cuenta con radiografías previas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:	a.Controlar con nueva radiografía de tórax en 3 meses b.Controlar con nueva radiografía de tórax en 6 meses c.Controlar con nueva radiografía de tórax en 12 meses d.Solicitar un TAC de tórax e.Realizar biopsia excisional
3. Un paciente de 50 años, en situación de calle, presenta un cuadro clínico compatible con una tuberculosis pulmonar, por lo que se solicitan baciloscopías de expectoración, que resultan positivas. Se inicia tratamiento antituberculoso, el que recibe por un mes (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol), sin embargo no acude a los controles posteriores y no termina su tratamiento. Usted lo recibe 4 meses después, con síntomas respiratorios, por lo que solicita nuevas baciloscopías, que resultan positivas. La conducta más adecuada es:	a.Retomar el tratamiento donde lo dejó b.Diagnosticar fracaso a tratamiento e iniciar tratamiento secundario c.Iniciar tratamiento con 2 fármacos: isoniazida y rifampicina d.Solicitar PPD y decidir conducta según resultado e.Reiniciar el tratamiento, desde el comienzo
4. Un paciente de 70 años consulta por malestar general, fiebre, tos con expectoración mucopurulenta y dolor tipo puntada de costado. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra derrame pulmonar izquierdo de un 60% del hemitórax. Se realiza pleurocentesis, obteniéndose un líquido con 1.200 células por mm3, con un 95% de polimorfonucleares, LDH: 210 UI/L, ADA: 110 UI/L y pH: 7,0. El diagnóstico más probable es:	a.Cáncer b.Derrame paraneumónico simple c.Tuberculosis pulmonar d.Trasudado pleural e.Empiema
5. Un niño de 2 años presenta un cuadro de fiebre hasta 41°C y malestar general marcado, asociado a tos disfónica y dificultad para respirar. Al examen físico está en malas condiciones generales, presenta estridor inspiratorio, uso de musculatura accesoria y se inclina hacia atrás para poder respirar. El diagnóstico más probable es:	a.Laringitis obstructiva b.Bronquiolitis aguda c.Neumonía d.Coqueluche e.Epiglotitis bacteriana
6. Un paciente de 65 años consulta por disnea y dolor tipo puntada de costado, de una semana de evolución. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural derecho de tamaño moderado. Se realiza toracocentesis y estudio del líquido pleural obteniéndose un líquido de color amarillo, transparente, con proteínas de 5 g/dl y LDH: 200 UI/L. Presenta 110 células por mm3, con un 90% de mononucleares y ADA de 10 UI/L. La LDH plasmática es 300 mg/dl y las proteínas plasmáticas son 7,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:	a.Derrame tuberculoso b.Derrame canceroso c.Derrame plaraneumónico simple d.Insuficiencia cardíaca e.Quilotórax
7. Un niño de 10 años, asmático, en tratamiento con fluticasona y salbutamol, consulta por un cuadro de disnea, que no ha cedido, a pesar del uso frecuente de salbutamol. Al examen se auscultan sibilancias bilaterales, inspiratorias y espiratorias y se observa uso de musculatura accesoria y taquipnea. ¿Qué examen es más adecuado para determinar la gravedad de este paciente?	a.PEF (flujo espiratorio máximo) b.Gases en sangre arterial c.Test de metacolina d.Espirometría e.Radiografía de tórax
8. Un paciente de 7 años presenta un cuadro de tos con expectoración mucosa de 15 días de evolución, que ha ido en aumento, hasta asociarse a disnea. Al examen físico se auscultan sibilancias bilaterales espiratorias y crepitaciones difusas, mayores en las bases. Su hermana de 14 años está con síntomas similares. El tratamiento para la patología descrita es:	a.Amoxicilina b.Azitromicina c.Ciprofloxacino d.Amoxicilina más ácido clavulánico e.Sintomático
9. Un paciente de 67 años, diagnosticado de EPOC tabáquico, en tratamiento con broncodilatadores de larga acción, consulta por disnea mayor a la habitual, asociada a cianosis y tos con expectoración. Se inicia oxígeno al 35%, evolucionando con compromiso de conciencia. Se solicitan gases arteriales, que son compatibles con una insuficiencia respiratoria aguda, de tipo global. La conducta más adecuada es:	a.Realizar nebulizaciones con corticoides b.Suspender el oxígeno c.Aumentar el oxígeno a 100% d.Realizar nebulizaciones con ipatropio y salbutamol e.Conectar a ventilación mecánica
10. Un paciente, diagnosticado de "disnea en estudio", se realiza una espirometría que demuestra VEF1: 56% del teórico, CVF: 60% del teórico, VEF1/CVF: 80%, que no mejora con broncodilatadores. El diagnóstico más probable, de entre los siguientes, es:	a.Asma b.Fibrosis pulmonar c.EPOC d.Bronquiectasias e.Hipertensión pulmonar primaria

Lia...

11. ¿Cuál de las siguientes medidas incide más en el pronóstico de un paciente diagnosticado de EPOC?	a.Realizar actividad física b.Abandonar el hábito tabáquico c.Usar corticoides inhalados d.Usar broncodilatadores de corta acción e.Usar broncodilatadores de larga acción
12. La asociación de matidez, crepitaciones y broncofonía, en un lóbulo pulmonar, sugiere un(a):	a.Derrame pleural b.Neumotórax c.Neumonía d.Cuerpo extraño e.Atelectasia
13. Un paciente de 20 años consulta por dolor tipo puntada de costado derecho. Se solicita radiografía de tórax, que muestra un neumotórax del 50% del campo pulmonar derecho. La conducta más adecuada es:	a.Administrar analgésicos intravenosos y controlar con una nueva radiografía en 6 horas b.Puncionar el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular c.Instalar una sonda pleural, conectada a trampa de agua d.Realizar ventilación mecánica no invasiva e.Resolver quirúrgicamente
14. El distrés respiratorio del adulto se produce por:	a.Aumento de la presión de la arteria pulmonar b.Aumento de la presión hidrostática a nivel capilar pulmonar c.Aumento de la presión oncótica a nivel capilar pulmonar d.Aumento de la presión oncótica intersticial e.Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar
15. Un niño de 12 meses ha presentado 3 episodios de obstrucción bronquial, los que respondieron bien después del manejo en urgencia durante dos horas con salbutamol inhalado y oxígeno. Usted lo recibe al día siguiente del tercer episodio, derivado por el médico de urgencias. No presenta otros síntomas, está en buenas condiciones, manteniendo algo de tos y su examen físico es normal. La indicación más adecuada es:	a.Indicar uso de salbutamol SOS b.Iniciar corticoides inhalados cada 12 horas y salbutamol SOS c.Iniciar salmeterol inhalado cada 12 horas y salbutamol SOS d.Solicitar espirometría e.Indicar salbutamol cada 6 horas por 3 meses
16. ¿Qué medicamento es más importante para prevenir la aparición de crisis asmáticas en un paciente asmático?	a.Betaagonistas de larga acción inhalados b.Corticoides inhalados c.Betaagonistas de corta acción inhalados d.Antihistamínicos orales e.Inhibidores del receptor de leucotrienos orales
17. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de disnea de inicio súbito. Al examen físico está angustiado, en buenas condiciones, con FR: 20x', saturación arterial 99% a FiO2 ambiental, presión arterial 120/80 mmHg, FC: 70x'. Su examen cardiopulmonar muestra un RR2T sin soplos y MP(+), sin ruidos agregados. Se solicita una radiografía de tórax, que resulta normal y niveles plasmáticos de dímero D, que resultan normales. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar anticoagulación con heparina b.Iniciar trombolisis con activador tisular del plasminógeno, recombinante (rTPA) c.Solicitar ecografía doppler de extremidades inferiores d.Solicitar angiografía pulmonar e.Descartar el diagnóstico de TEP
18. Un paciente sufre un accidente de tránsito, resultando con un golpe en el tórax. Evoluciona con disnea y caída de la saturación arterial de oxígeno. Al examen físico se auscultan crepitaciones difusas bilaterales y la radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares de tipo alveolar, en distintas zonas de los pulmones. El diagnóstico más probable es:	a.Hemotórax b.Lesión traqueal c.Neumonía d.Contusión pulmonar e.tromboembolismo pulmonar
19. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de fiebre y tos con expectoración, asociado a malestar general intenso y disnea. Al examen físico está taquipneico con 35 rpm, satura 85% a FiO2 ambiental y se auscultan crepitaciones en la base pulmonar derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra una imagen de condensación de los lóbulos medio y superior derecho. El tratamiento más adecuado es:	a.Clindamcicina b.Ceftriaxona c.Amoxicilina d.Amoxicilina + ácido clavulánico e.Moxifloxacino

Lia...

CUESTIONARIO RESPIRATORIO 3	2024
1. Un paciente de 59 años, diagnosticado de fibrosis pulmonar, consulta por fiebre hasta 38,6°C, asociado a malestar general y tos con expectoración mucopurulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones, satura 95% a FiO2 ambiental y tiene una frecuencia cardíaca de 90x'. El examen pulmonar muestra crepitaciones difusas, compatibles con su patología de base. Se solicita una radiografía de tórax que muestra imágenes compatibles con fibrosis pulmonar, asociadas a una zona de relleno alveolar en el lóbulo superior izquierdo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?	a.Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina b.Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico c.Indicar tratamiento endovenoso con ceftriaxona d.Indicar tratamiento endovenoso con ceftazidima más clindamicina e.Indicar tratamiento endovenoso con ceftriaxona más metronidazol
2. Un paciente de 60 años consulta por disnea de esfuerzos desde hace un mes, que aparecen al caminar una cuadra. Además, presenta tos, sin expectoración. Al examen físico presenta hipocratismo digital y crepitaciones pulmonares intensas, bilaterales, mayores en las bases pulmonares. El diagnóstico de sospecha es:	a.Neumonía atípica b.Fibrosis pulmonar c.EPOC d.Asma e.Cáncer pulmonar
3. Un paciente consulta por dolor torácico, tipo puntada de costado, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado. Se procede a la toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural amarillo, transparente, con pH: 7,30, lactato: 2,5 mmol/L, LDH: 190 UI/L, proteínas: 4,0 g/L, células: 560 por mm3, con 90% de mononucleares. La LDH plasmática es 250 U/L y las proteínas plasmáticas son 7,0 g/dL. El diagnóstico más probable es:	a.Empiema b.Derrame paraneumónico simple c.Tuberculosis pleural d.Tromboembolismo pulmonar crónico e.Insuficiencia cardíaca
4. El distrés respiratorio del adulto requiere para su diagnóstico la presencia de:	a.Presión arterial menor a 140/90 mmHg b.Ausencia de hipertensión pulmonar c.Presión capilar pulmonar menor a 18 mmHg d.Ausencia de patologías pulmonares de base e.Normalidad de la Pa/Fi (cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno)
5. Un paciente consulta por un cuadro de 2 días de evolución de rinorrea abundante, asociada a estornudos y malestar general. Además, ha presentado fiebre hasta 38°C, sensación de descarga posterior, hiposmia y obstrucción nasal. El examen físico sólo muestra rinorrea mucosa y eritema faríngeo, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:	a.Indicar tratamiento sintomático b.Solicitar TAC de cavidades paranasales c.Iniciar amoxicilina oral d.Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico oral e.Solicitar nasofibroscopía
6. Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, presenta taquipnea y quejido al nacer. Al examen físico presenta crepitaciones pulmonares escasas y satura 90%, normalizándose con O2 al 28%. El diagnóstico más probable es:	a.Enfermedad de membrana hialina b.Hipertensión pulmonar persistente c.Síndrome de aspiración de meconio d.Taquipnea transitoria del recién nacido e.Neumonía neonatal
7. La asociación de dolor tipo puntada de costado, disminución del murmullo pulmonar e hipersonoridad a la percusión torácica es característica de:	a.Tromboembolismo pulmonar b.Neumonía c.Neumotórax d.Atelectasia e.Cuerpo extraño bronquial
8. Identifique la asociación CORRECTA entre la patología y el mecanismo de hipoxemia:	a.Alteración neuromuscular - Trastorno V/Q b.Neumonía - Shunt c.EPOC - Trastorno de la Difusión d.Fibrosis pulmonar - Hipoventilación e.Tromboembolismo pulmonar - Shunt
9. Un paciente EPOC crónico, en tratamiento con broncodilatadores, consulta por la opción de uso de oxígeno domiciliario. Lo más correcto es indicarle que:	a.Está indicado en todos los pacientes con EPOC b.Está indicado solo en aquellos pacientes que continúan fumando c.Está indicado solo en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica grave, o con comorbilidades específicas d.Está indicado solo en pacientes con síntomas a pesar del uso de corticoides y broncodilatadores e.Está indicado solo en pacientes con disnea de reposo

Lia...

10. Un niño de 3 años presenta un cuadro de dificultad respiratoria, asociado a estridor inspiratorio. La madre refiere que el día de ayer comenzó con fiebre hasta 38°C, disfonía y tos disfónica. No presentó mayor compromiso del estado general, pero que desde hace 20 minutos se le agregó disnea y respiración ruidosa. El agente etiológico más probable es:	a.Virus respiratorio sincicial b.Virus influenza c.Virus parainfluenza d.Neumococo e.Haemophilus influenzae
11. ¿Qué tratamiento antibiótico le parece más adecuado para un paciente cursando una neumonía grave, que requiere ventilación mecánica y uso de drogas vasoactivas?	a.Ceftriaxona sola b.Ceftriaxona + penicilina c.Clindamicina + penicilina d.Ceftriaxona + levofloxacino e.Cefotaximo + metronidazol
12. Un paciente de 40 años, sin antecedentes ni hábitos de importancia, hace 2 años sufre una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, la que fue tratada con antibióticos, con buena respuesta. Sin embargo, evoluciona posteriormente con broncorrea crónica, mayor en las mañanas, que en ocasiones viene acompañada de expectoración hemoptoica. El diagnóstico más probable es:	a.Cuerpo extraño bronquial b.Tuberculosis c.Cáncer pulmonar d.Bronquitis crónica e.Bronquiectasias
13. Una paciente es diagnosticada de tuberculosis bacilífera, por lo que inicia tratamiento antituberculoso, con 4 drogas por 2 meses y luego con 2 drogas por 4 meses más. Las baciloscopías negativizaron al segundo mes de tratamiento y presentó mejora sintomática. Acude 4 meses después de haber terminado el tratamiento, con tos y expectoración, por lo que se solicita una nueva baciloscopía, que resulta positiva. El diagnóstico es:	a.Fracaso b.Abandono c.Recaída d.Infección por Nocardia sp. e.Infección por Mycobacterium avium
14. Un paciente de 10 años presenta tos nocturna y sibilancias luego de realizar deporte o durante las infecciones respiratorias virales. Al examen físico sólo presenta alargamiento de la espiración. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?	a.Test de difusión de CO b.Espirometría c.Prick test d.Radiografía de tórax e.TAC de tórax de cortes finos
15. Un paciente cursando un síndrome neumónico, se realiza una radiografía, que visualiza una zona de condensación en el lóbulo inferior izquierdo, asociado a un derrame pleural que abarca el 25% inferior del campo pulmonar izquierdo. La conducta más adecuada es:	a.Instalar un tubo pleural y administrar antibióticos por vía endovenosa e intrapleural b.Iniciar antibióticos y realizar pleurocentesis, con análisis del líquido pleural y decidir conducta según hallazgos c.Iniciar ceftriaxona, asociada a fármacos antituberculosos d.Iniciar antibióticos y solicitar biopsias pleurales e.Indicar ceftriaxona + clindamicina y controlar evolución
16. Acude a urgencias un paciente de 20 años, con un cuadro sugerente de un neumotórax espontáneo. Además tiene antecedente de haber sufrido uno, el año pasado, el que fue manejado con pleurocentesis. Se solicita una radiografía de tórax, que confirma el diagnóstico, demostrando la presencia de un neumotórax derecho, del 30% del campo pulmonar. La conducta más adecuada es:	a.Administrar analgésicos y observar evolución por 4 a 6 horas, controlando con una nueva radiografía de tórax b.Realizar aspiración con jeringa y llave de 3 pasos c.Iniciar analgesia e instalar un tubo pleural con trampa de agua, sin necesidad de cirugía d.Conectar a ventilación mecánica con presión positiva e.Resolver quirúrgicamente
17. Un paciente EPOC, presenta marcado aumento de la disnea de 24 horas de evolución, que en las últimas horas se volvió intensa incluso en el reposo. Al examen físico presenta cianosis y taquipnea importante. Se solicitan gases arteriales que muestran PaO2: 45 mmHg, PaCO2: 65 mmHg y pH: 7,26. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar oxígeno al 100% y nebulizarlo con salbutamol de inmediato b.Administrar corticoides endovenosos y realizar nebulizaciones con salbutamol c.Conectar a ventilación mecánica no invasiva d.Realizar nebulizaciones con corticoides y broncodilatadores de larga acción e.Administrar aminofilina endovenosa, albutamol inhalado y oxígeno por mascarilla de recirculación
18. ¿Cuál de los siguientes tratamientos le parece más adecuado para un paciente asmático, que presenta síntomas 1 a 2 veces por semana, los que controla con salbutamol?	a.Mantener el salbutamol SOS b.Agregar salmeterol inhalado cada 12 horas c.Agregar fluticasona inhalada cada 12 horas d.Agregar aspirina oral cada 12 horas e.Agregar ipatropio SOS, asociado con el salbutamol
19. Se obtienen los siguientes gases arteriales PaO2: 80mmHg, PaCO2: 30 mmHg, pH: 7.47, HCO3: 21 mmol/l. ¿A qué estado	a.Alcalosis respiratoria b.Alcalosis metabólica

ácido base corresponden?	c.Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica d.Alcalosis mixta e.Gases venosos
20. ¿Qué histología del cáncer pulmonar se asocia más frecuentemente a un síndrome paraneoplásico?	a.Espinocelular b.Células pequeñas c.Adenocarcinoma d.Carcinoma bronquioloalveolar e.Células grandes

Lia...